評価の説明

※以下の評価基準は公的なものではありません。一般的な基準をもとに作成しています。

1. 指標別：評価点（スコアリング）構成表

各指標（0〜4点）の算出基準と、その数値が示す現場の状態を示します。

点数	病床利用率（安定性）	病床稼働率（現場負荷）	病床回転率（効率性:月間）	指標の解釈（ニュアンス）
4点	90%以上	95%以上	2.5回以上	卓越： 地域の需要を独占し、極限までリソースを活用している状態。
3点	85%以上	90%以上	2.0回以上	優良： 収益性と医療提供のバランスが取れた理想的な運用
2点	75%以上	80%以上	1.5回以上	標準： 平均的な状態。大きな問題はないが改善の余地あり
1点	60%以上	70%以上	1.0回以上	低迷： 活気が不足。空床や滞留の兆候が見られる。
0点	60%未満	70%未満	1.0回未満	著しく低い状態

2. 合計点・ランクと【診断】対応表

合計点から算出される総合ランクと、点数の組み合わせから推定する診断内容です。

ランク	合計点	診断ニュアンスの代表例	診断の視点（判断ロジック）
S	11〜12	【超高効率】地域の中核として完璧な稼働。	全指標がトップ水準であり、現状維持が最大の課題です。
A	8〜10	【急性期特化】回転は速いが空床が目立つ。	病床回転率の点数が高い ＝ 腕は良いが、集患が課題。
		【地域密着型】安定しているが患者が滞留気味。	病床利用率の点数が高い ＝ 信頼はあるが、退院支援が課題。
B	5〜7	【機能過剰】運用能力は高いが需要不足。	病床回転率の点数は高いが病床利用率が低い ＝ 紹介元営業を。
		【停滞傾向】満床に近いが入れ替わりがない。	病床利用率の点数は高いが病床回転率が低い ＝ 長期入院の是正を。
C	2〜4	【固定化リスク】病床は埋まっているが機能不全。	病床回転率がほぼゼロ。療養への機能転換を検討。
		【低活動】集患と運用の両面に課題あり。	全指標が平均以下。体制の抜本的見直し。
D	0〜1	【構造改革対象】存続の危機。早期の判断を。	経営維持が困難なレベル。事業再編の対象。

3. 分析を読み解くための「視点」ガイド

診断を下す際に重視している「乖離（ギャップ）」の読み解き方です。

・病床回転率の点数 ＞ 病床利用率の点数　→　医療技術や運用効率は高いものの、紹介患者が不足している可能性があります。
・病床利用率の点数 ＞ 病床回転率の点数　→　患者は多いものの、退院調整が遅れておりベッドが滞留している状態です。
・病床稼働率の点数 ＞ 病床利用率の点数　→　入退院手続きやベッドメイクなどの業務負荷が高く、実際の入院患者数に対して効率が低い可能性があります。

4. 各指標の計算式と評価

病床利用率	計算式：一日平均入院患者数／病床数（許可病床または稼働病床）×100 一般的に「動かせるベッド数」に対して、実際に使用されたベッド数（延べ患者数）の割合を示す指標です。 90%以上　満床に近い状態。収益性は高いが緊急入院の余力は少ない 85%以上　理想的な運用状態 75%以上　標準的 60%以上　稼働にムラがあり改善余地あり 60%未満　赤字リスクが高い状態
病床稼働率	計算式：(一日平均入院患者数 ＋ 一日平均退院数)／病床数×100 ※一日平均退院数は、一日平均患者数 ÷ 平均在院日数で推計します。 退院当日の空床（入れ替えによる稼働）を含めた実質的な稼働率を評価します。 95%以上　フル稼働 90%以上　高効率運用 80%以上　標準的運用 70%以上　低活動 70%未満　停滞
病床回転率（回/年）	計算式：年間新入院患者数／病床数 ※近似式：(一日平均入院患者数 ×365)／平均在院日数÷病床数 　月間回転数は上記数値を 1/12 して算出します。 2.5回以上／月(30.0 以上／年)　　超高速循環 2.0回以上／月(24.0 〜 29.9／年)　高効率運用 1.5回以上／月(18.0 〜 23.9／年)　標準的 1.0回以上／月(12.0 〜 17.9／年)　長期化傾向 1.0回未満／月(12.0 未満／年)　　停滞・固定化
病床回転間隔	計算式：（病床数×日数×延べ入院患者数）／退院患者数 ※近似式：（365÷年間病床回転率）－ 平均在院日数 0.5日〜1.0日未満　極めて効率的 1.0日〜2.0日　　標準的・良好 3.0日以上　　要改善 急性期病棟では1日前後が目安となります。 療養・慢性期病棟では2〜3日以内に抑えることが健全経営の目安です。
補足	病院経営の理想は「平均在院日数の短縮」と 「病床利用率の維持・向上」を同時に実現することです。 そのためには医療の質の向上 ・地域連携 ・診療報酬制度（DPCなど）への対応 など複合的な取り組みが必要になります。
病床利用率の計算式の説明	厚生労働省には、病床数、一日平均入院患者数、平均在院日数の3種類が報告されています。 ◇**病床利用率の計算式** 病床利用率（%）＝年間在院患者延数÷（運用病床数×365）×100 ですが、 今回指標にない**年間在院患者延数**は、1日平均入院患者数 × 365日または病床数 × 病床稼働率 × 365日で逆算します。 年間在院患者延数 ＝ 1日平均入院患者数 × 365日 例：病床数**600床**、一日平均入院患者数**522.9人**、平均在院日数**13.3日** 病床利用率（%）：(522.9人×365日)÷600床×365日×100 ＝ 87.15%
病床稼働率の計算式の説明	厚生労働省には、病床数、一日平均入院患者数、平均在院日数の3種類が報告されています。 ◇病床稼働率の計算式 計算式：(一日平均入院患者数 ＋ 一日平均退院数)／病床数×100 ですが、 今回指標にない**一日平均退院患者数**は、一日平均入院患者数 ÷ 平均在院日数で推計します。 例：病床数**600床**、一日平均入院患者数**522.9人**、平均在院日数**13.3日** 病床稼働率（%）：522.9人 ＋（522.9人÷13.3日）÷600×100 ＝93.7%

【出典】GemMed　株式会社WorkVision　大塚商会　コトセラ　群馬県済生会前橋病院

※本資料は病床利用率・病床稼働率・病床回転率の3つの指標を基にした簡易分析です。 実際の医療経営分析では、さらに多くの指標を組み合わせて評価が行われます。 また、地域特性によっては評価点が低くても重要な役割を担う医療機関も存在します。
簡易的なベンチマークとしてご利用ください。

制作者名：Mana48FanClub
メールアドレス：mana48.hmc.club001@ymail.ne.jp

最終更新日：2026年3月